



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN TATALAKSANA AWAL
ACUTE HEART FAILURE
TAHUN 2024

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

TOR

“Tatalaksana Awal *Acute Heart Failure*”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian gagal jantung akut atau *acute heart failure* di dunia berdasarkan data *European Society of Cardiology* (ESC) menunjukkan bahwa sebanyak 65-75% dari 186,364 pasien tersebut mempunyai riwayat gagal jantung dengan rerata usia berkisar 70-73 tahun. Data ini dikumpulkan dari Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Turki, Sub-Sahara Afrika dan berbagai negara yang sudah tergabung dalam Benua Eropa. Asia Tenggara menempati posisi ketiga setelah Afrika dan India sebagai daerah dengan angka mortalitas gagal jantung tertinggi. Negara-negara di Asia dengan angka mortalitas tinggi pada pasien yang dirawat adalah Korea Selatan dan Thailand yaitu sebesar 6%. Persentase ini terbilang tinggi dibandingkan negara lain di Asia. Sebuah data dari Reyes (2013) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka mortalitas pasien gagal jantung sebesar 17%.

Gagal jantung akut digambarkan sebagai kondisi darurat yang memerlukan penanganan yang segera karena tipe serangan yang cepat ini membutuhkan diagnosis dan terapi yang segera karena dapat mengancam nyawa. Terdapat banyak faktor yang berperan dalam kejadian *acute heart failure* seperti disfungsi miokardium akut karena iskemia, inflamasi, penggunaan obat-obatan, gangguan nutrisi, penyakit endokrin, atau toksin. Penyebab lain juga berasal dari perburukan gagal jantung yang ditandai dengan dekompensasi dikarenakan kurangnya edukasi mengenai pengobatan, aritmia, infeksi, anemia, dan lainnya. Banyaknya klasifikasi yang digunakan dapat membantu dalam menilai tingkat resiko komplikasi dan dapat membantu dalam memberikan terapi yang tepat pada pasien dalam kondisi darurat.

Pemeriksaan lebih lanjut yang perlu dilakukan untuk mengonfirmasi kondisi pasien dapat dibantu dengan elektrokardiografi (EKG), foto toraks, ekokardiografi, kateterisasi jantung, serta pemeriksaan biomarker *B-type natriuretic peptides* (BNP) dan *N-terminal pro hormone B-type natriuretic peptides* (NT-pro BNP). Pemeriksaan ini dapat membantu mengkonfirmasi penyebab gagal jantung akut baik yang bersifat kardiak maupun non-kardiak. Setelah memahami kondisi pasien dengan pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat diberikan terapi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, terapi yang dilakukan untuk *acute heart failure* terbagi atas farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi farmakologis yang digunakan untuk *acute heart failure* yaitu golongan diuretik, penyekat enzim konversi angiotensin (EKA), vasodilator, vasopressor, dan inotropik. Selain itu, terapi non-farmakologis yang digunakan adalah terapi oksigen, transplantasi jantung, *left ventricular assist device* (LVAD), dan *implantable cardiac defibrillator* (ICD).



Berdasarkan tingginya prevalensi dan mortalitas yang disebabkan oleh *acute heart failure*, maka perlu dilakukan ulasan mendalam mengenai diagnosis dan tatalaksana terkini gagal jantung akut untuk mengetahui pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan perkembangan tatalaksana terkini *Acute Heart Failure*.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. PMK no 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKE/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan dokter maupun tenaga kesehatan dalam menangani pasien gagal jantung akut (*acute heart failure*)
2. Penanganan pasien gagal jantung akut tepat dan akurat
3. Kendali mutu dan kendali biaya sesuai
4. Meminimalisir maupun meniadakan terapi yang tidak dibutuhkan pasien

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia

1. Penanggung Jawab

: Rofi’atal Manzilah, S.Psi
2. Sekretaris

: Mami Susanti, A.Md.Kep.
3. Sie Acara

: Tamara Putri Yunisma, S.Psi
4. IT & Dokumentasi

: Galih Satria Mahardika, S.Pd

Wahyu Agung Nurcahyo, S.Kom
5. Narasumber

: dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP

2.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan diadakan pada :

- Hari

: Sabtu
- Tanggal

: 20 April 2024
- Tempat

: Hall Sakura lt. 3 RS PH Sukorejo dan Zoom Meeting (*Hybrid*)
- Pukul

: 14.00-16.00 WIB

Dengan rangkaian acara sebagai berikut :

No.	Pukul	Acara	Narasumber / PIC	JP
1.	14.00 – 14.10	Pembukaan Mengisi Pre-Test	Rofi’atal Manzilah, S.Psi	3
2.	14.10 – 15.30	Materi tatalaksana awal <i>accute heart failure</i>	dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP	
3.	15.30 – 15.45	Sesi tanya jawab dan diskusi	dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP	1
4.	15.45 – 15.55	Mengisi Post-Test	Rofi’atal Manzilah, S.Psi	
5.	15.55 – 16.00	Pengumpulan lembar/dokumen resume Penutupan Registrasi Peserta	Rofi’atal Manzilah, S.Psi	
Total JP				4

2.3 Sasaran atau Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari :

No.	Profesi / Unit	Jumlah
1.	Dokter Umum IGD	7
2.	Staf IGD	25
3.	Staf ICU	14
Total Peserta		46 Peserta

2.4 Media

Daftar media yang dibutuhkan :

No.	Daftar Media	Jumlah Kebutuhan (pcs)
1.	Laptop	1
2.	Sound system	1
3.	Microphone	1

4.	LCD	3
5.	Materi	1

2.5 Metode

Metode penyampaikan kegiatan pendidikan dan pelatihan :

- a. Kuliah Pakar (lecture)
- b. Skill Practice

2.6 Kebutuhan Anggaran

Anggaran dana kegiatan pelatihan :

No.	Deskripsi	Anggaran Biaya	Sumber Dana/Vendor
1.	Fee Narasumber 1. dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP	Rp250.000	PT. Disa Prima Medika
2.	Konsum Pemateri	Rp25.00	Dapur
3.	Konsum Panitia	Rp20.000	Dapur
TOTAL		Rp295.000	
Yang Diajukan ke PT. Disa Prima Medika		Rp250.000	



BAB III
MONITORING EVALUASI

3.1 Monitoring

Monitoring pada saat persiapan, pelaksanaan, pembuata laporan serta aplikasi di lapangan. Pada saat perencanaan dilakukan rapat koordinasi bersama membahas tentang persiapan kegiatan kemudian dilanjutkan pelaksanaan kegiatan.

3.2 Evaluasi

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan evaluasi pre dan post test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta pelatihan selama menjaalani kegiatan pelatihan. Selanjutnya dilakukan pembuatan laporan yang terkait hasil pelatihan untuk dilaporkan ke SDM RS Prima Husada Sukorejo dan PT Disa Prima Medika. Kemudian dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada saat aplikasi di lapangan yang dapat berupa supervisi.

BAB IV
PENUTUP

Demikian TOR atau proposal kegiatan “Pelatihan Tatalaksana Awal *Acute Heart Failure*” ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan. Untuk itu, dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara tersebut.

Pasuruan, 13 April 2024

Mengetahui,
Kepala Unit SDM & Diklat
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)
Novia Ainur Pratiwi, S.KM

Penanggung Jawab Kegiatan,
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)
Rofi'atal Manzilah, S.Psi

Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS